

Deficit Intellettivo

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 07 · 30/03/2026

Oggi si entra nel vivo: il deficit intellettivo è l'utenza con cui lavorerà la maggior parte degli operatori sociali. Capire bene cos'è — e cosa NON è — fa la differenza tra un intervento efficace e uno che va nel vuoto.

Che cos'è il Deficit Intellettivo

La definizione di riferimento viene dall'**AAIDD** (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2022):

La disabilità intellettiva è caratterizzata da **limitazioni significative** sia nel **funzionamento intellettivo** sia nel **comportamento adattivo**, che si manifestano nelle abilità adattive concettuali, sociali e pratiche. Tale disabilità ha **origine durante il periodo dello sviluppo**, definito operativamente come il periodo precedente il compimento dei **22 anni di età**.

Questa definizione si regge su **tre criteri**, tutti e tre necessari per fare diagnosi:

1. **Funzionamento intellettivo** significativamente limitato (QI < 70–75)
2. **Comportamento adattivo** significativamente limitato (almeno in uno dei tre domini)
3. **Origine nel periodo dello sviluppo** (prima dei 22 anni)

Se manca anche uno solo dei tre, la diagnosi non è possibile. Questo è il punto che spiega perché il DI riguarda l'1–1,5% della popolazione e non il 2,3% (tutti quelli sotto QI 70): alcune persone hanno QI basso ma si adattano bene — e non ricevono la diagnosi.

A. Il Funzionamento Intellettivo

Funzionamento intellettivo è un termine più ampio di "intelligenza" e più ristretto di "funzionamento umano". Non si riduce a "sai fare i conti?" — comprende:

- difficoltà nel pensare e nell'apprendere
- lentezza di apprendimento
- difficoltà nel ragionare e nel pianificare
- difficoltà nell'imparare dall'esperienza

Per misurarlo si usa il **QI** (Quoziente Intellettivo). La soglia diagnostica è un QI **inferiore a 70**, corrispondente a due o più deviazioni standard sotto la media (che è 100, con deviazione standard 15).

Breve storia del QI

Nel **1904** il ministero francese dell'Istruzione incarica una commissione di trovare metodi per identificare i bambini con sviluppo intellettivo subnormale. Ne fa parte **Alfred Binet**, che con Theodore Simon pubblica nel **1905** la prima **Scala metrica dell'intelligenza** (Binet-Simon): 30 problemi calibrati per età, che misuravano comprensione, ragionamento e giudizio, evitando le nozioni scolastiche pure.

Binet è considerato il **padre della psicometria** — la scienza che misura e classifica l'intelligenza tramite test standardizzati.

Età mentale: un bambino di 7 anni che risolve i problemi tipici dei 7 anni ha età mentale = 7. Se risolve quelli da 9 anni, età mentale = 9.

Il problema con la differenza semplice (es. "ha 2 anni di ritardo") è che non scala bene: 2 anni di ritardo a 5 anni sono gravissimi, a 14 anni sono trascurabili. Per questo si passò al **rapporto** (età mentale / età cronologica $\times$ 100) → il QI. Il termine "quoziente" si deve a **Stern**.

Formula classica:

$$QI = (Et\grave{a} \text{ Mentale} / Et\grave{a} \text{ Cronologica}) \times 100$$

Esempi: EM 12 / EC 10 → QI 120 | EM 10 / EC 12 → QI 83

Oggi il calcolo è molto più complesso, ma il termine QI è rimasto. La versione attuale è la **Scala Stanford-Binet** e i test **Wechsler**.

La curva di Gauss e il QI

Se si somministra il test a tutta la popolazione e si tracciano i risultati, si ottiene una **curva a campana (curva di Gauss)**:

Fascia QI	% della popolazione
Sopra 130	2,3%
115–130	13,6%
85–115	68,2% (la "norma")
70–85	13,6%
Sotto 70	2,3%

La maggior parte delle persone ottiene punteggi tra 85 e 115. Chi scende sotto 70 è il 2,3% — ma, come detto, la diagnosi di DI tocca solo l'1–1,5% perché richiede anche il criterio del comportamento adattivo.

Attenzione: i limiti del QI

Il numero grezzo del QI dice poco sulla persona reale: non dice cosa sa fare, come funziona nella vita quotidiana, né quali passi intraprendere. Un profilo funzionale completo è molto più utile per la pratica educativa.

Detto questo, il QI resta necessario per accedere a diagnosi e prestazioni. Non si è ancora trovata un'alternativa migliore.

Un punto critico importante: i **test devono essere somministrati nella lingua madre** e con le dovute discriminanti culturali. Negli anni '50–'70 l'esercito americano somministrò il test agli afroamericani ottenendo risultati falsamente

bassi — non perché fossero meno intelligenti, ma perché avevano avuto meno accesso all'istruzione. Un errore scientifico gravissimo che portò a conclusioni razziste.

B. Il Comportamento Adattivo

Il **comportamento adattivo** è l'insieme di abilità concettuali, sociali e pratiche apprese per funzionare nella vita quotidiana. Questo secondo criterio spiega perché due persone con lo stesso QI possono avere funzionamenti quotidiani completamente diversi.

È evolutivo: aumenta di complessità con l'età. È valutato: - sulla base delle **prestazioni tipiche** (non quella migliore) a casa, a scuola, al lavoro, nel tempo libero - in riferimento agli **ambienti di vita tipici** per l'età e la cultura

Per la diagnosi serve un punteggio almeno 2 deviazioni standard sotto la media in **almeno uno** dei tre domini:

Tre domini del comportamento adattivo

Abilità concettuali: - Ridotta pianificazione autonoma e pensiero astratto - Difficoltà a scegliere una buona soluzione di fronte a un problema - Difficoltà nell'uso efficace di simboli (tempo, matematica) - Difficoltà a comunicare pensieri e idee - Difficoltà nella gestione di sé e nell'organizzare le attività future - Difficoltà ad anticipare le conseguenze del proprio comportamento - Problemi con lettura, scrittura, aritmetica - Difficoltà con il denaro e i concetti economico-finanziari

Abilità sociali: - Risposta e giudizio sociale inadeguati - Tendenza a negare o minimizzare la propria disabilità - Forte desiderio di compiacere le figure di autorità, basato su comprensione limitata della situazione - Credulità, ingenuità e suggestionabilità - Maggiore vulnerabilità e rischio di vittimizzazione - Difficoltà a lavorare con gli altri nella risoluzione di problemi di gruppo

Abilità pratiche: - Limitazioni nella cura di sé e nelle abilità domestiche - Difficoltà a ottenere e mantenere un lavoro stabile (gestire conflitti, lavorare sotto pressione) - Limitazioni nell'uso del denaro (dare il resto, pagare le bollette, non

cedere beni a chi non paga) - Difficoltà a mantenere un ambiente sicuro per sé e per gli altri

Attenzione: **non è che ogni persona con DI ha tutte queste caratteristiche.** Sono esempi di possibili limitazioni — ciascuna persona è un insieme unico di difficoltà e punti di forza.

C. Età di Esordio

La disabilità deve avere origine durante il **periodo dello sviluppo**, prima dei **22 anni**. Questo criterio serve a distinguere il DI dalla **demenza**: un anziano che perde capacità cognitive ha una demenza, non un DI. Le perdite di capacità in età adulta non rientrano nella diagnosi.

Il limite di 22 anni è stato scelto arbitrariamente (prima era 18, poi 20) per non escludere le poche persone che potrebbero ricevere diagnosi tardiva in giovane età adulta. La maggior parte delle diagnosi viene fatta nella **prima infanzia**.

Terminologia: deficit intellettivo, ritardo mentale, disabilità cognitive

Qui si fa spesso confusione. Chiariamo una volta per tutte:

Deficit intellettivo / Disabilità intellettiva → il termine corretto oggi. Stessa popolazione che prima veniva chiamata con "ritardo mentale".

"Ritardo mentale" → termine obsoleto, da non usare. Il termine "ritardo" implica solo uno sviluppo più lento, ma ci sono anche differenze qualitative nei traguardi cognitivi finali. È fuorviante e da abbandonare — anche se lo sentirete ancora in giro.

Disabilità cognitive → termine più ampio, un "cappello" che include: - Deficit intellettivo - Disturbi dell'apprendimento (dislessia, discalculia...) - Deficit attentivi (ADHD) - Difficoltà cognitive tipiche dell'autismo con QI normale - Disabilità

sensoriali (un bambino non vedente può avere carenze cognitive percettive senza avere un DI)

Non tutte le disabilità cognitive sono disabilità intellettive. Tutte le disabilità intellettive sono disabilità cognitive.

Pensa a un albero: la disabilità intellettiva è un ramo dentro l'albero più grande delle disabilità cognitive.

Classificazione del DI per intensità

Le classificazioni più vecchie usavano il QI per suddividere il DI in livelli. Questa tabella è ancora usata:

Livello	QI	Intensità dei sostegni necessari
Gravissimo	0–20/25	Continuo
Grave	20/25–40/45	Estensivo
Medio/medio-grave	40/45–55	Limitato
Leggero/lieve	55–70/75	Intermittente

Il prof sottolinea che questa classificazione è "un po' tutto e niente": nella pratica, una persona definita "lieve" può avere capacità molto limitate, e viceversa. La tendenza attuale è classificare non per QI ma per **intensità del bisogno di sostegno** — molto più utile per la pratica quotidiana.

Soglia del QI: perché è passata da 75 a 70?

Abbassare la soglia da 75 a 70 significa che meno persone rientrano nella diagnosi. Chi ha QI tra 70 e 75 ora non ha più diritto alle prestazioni, pur avendo funzionamento limite. Il prof esprime posizione critica: non è una decisione puramente scientifica — ci sono anche pressioni politiche ed economiche (meno diagnosi = meno prestazioni = meno spesa pubblica). Come operatori e cittadini, vale la pena esserne consapevoli.

Prevalenza

Il **DSM-5** stima che l'**1–1,5%** della popolazione generale abbia un deficit intellettivo. I tassi variano tra paesi perché variano le cause: carenze alimentari, consumo di alcol, qualità della medicina, inquinamento. Paradossalmente, i paesi con medicina avanzata hanno più persone con DI in vita perché salvano neonati prematuri che altrove non sopravviverebbero.

Eziologie (cause)

Il DI è la "via finale comune" di molti processi patologici che agiscono sul sistema nervoso centrale.

Causa	% circa
Alterazioni precoci dello sviluppo embrionale	30%
Problemi durante gravidanza e periodo perinatale	10%
Causa ereditaria	5%
Condizioni mediche acquisite nell'infanzia	5%
Influenze ambientali e altri disturbi mentali	15–20%
Causa sconosciuta	30–40%

Fattori di rischio per periodo

Prenatale (prima della nascita): - Anomalie cromosomiche e genetiche, sindromi - Povertà e malnutrizione della madre - Violenza domestica, mancato accesso alle cure - Uso di sostanze stupefacenti — praticamente tutte le droghe hanno effetti gravi sull'embrione - **Alcol**: anche piccole quantità quotidiane (un bicchiere di vino al giorno) possono causare la **Sindrome Alcolica Fetale** — un dato molto sottovalutato

Perinatale (durante/intorno al parto): - Prematurità: i grandi prematuri nei paesi occidentali sopravvivono sempre di più, ma non è prevedibile chi avrà sequele permanenti - **Ipossia** (mancanza di ossigeno al cervello)

Postnatale (dopo la nascita): - Traumi cerebrali, meningoencefalite - Malnutrizione, deprivazione sociale - Mancanza di stimolazione adeguata da parte dei caregivers - Situazioni di povertà prolungata, istituzionalizzazione

I Sistemi di Sostegno

Fin qui: diagnosi e classificazione. Ma tutto questo serve a un solo scopo: **progettare sostegni adeguati.**

Due presupposti fondamentali

1. Lo scopo principale della descrizione delle limitazioni è **sviluppare un profilo dei sostegni necessari**
2. Con **sostegni adeguati, personalizzati e prolungati nel tempo**, il funzionamento della persona con DI generalmente **migliora**

I sostegni non eliminano la disabilità — ma ne riducono l'impatto e migliorano la qualità di vita. La differenza più rilevante tra persone con DI e popolazione generale è che le prime necessitano di **diversi tipi e intensità di sostegni** per partecipare pienamente alla società.

Caratteristiche dei sistemi di sostegno efficaci

I sistemi di sostegno efficaci sono (AAIDD 2022):

Caratteristica	Cosa significa in pratica
Centrati sulla persona	La persona al centro: bisogni, desideri, aspettative — non solo i deficit
Completi	Coprono tutti i contesti di vita, non solo uno
Coordinati	

Caratteristica	Cosa significa in pratica
	Qualcuno coordina la rete (genitori, operatori) — senza coordinamento, il sistema si frammenta
Orientati agli esiti	Devono avere impatto misurabile e reale nella quotidianità

Valori dei sistemi di sostegno

Sono costruiti intorno a valori che coincidono con le dimensioni della qualità di vita:

- Autonomia e scelta personale - Relazioni interpersonali - Inclusione sociale - Diritti - Benessere emotivo, fisico, materiale

Tipologie di sostegno

Sostegni naturali (generici): - Famiglia, amici, vicini, colleghi, autisti dei mezzi pubblici - Tecnologia e dispositivi assistivi (protesi, sedia a rotelle) - Ambienti inclusivi

Sostegni specialistici: - Operatori sociali, psicologi, terapisti, insegnanti di sostegno - Didattica speciale e procedure psicoeducative mirate - Sensibilizzazione e educazione dell'opinione pubblica (sostegni socioculturali)

Il nuovo paradigma — come spiega Cottini (2016) — sposta lo sguardo dal "prendersi cura dell'individuo con i suoi deficit" all'**investire in reti di sostegno diffuse** in ogni ambiente in cui la persona vuole o ha necessità di stare. Questo non elimina il ruolo dell'operatore specializzato, ma lo integra con sostegni più naturali e diffusi.

Zona di Sviluppo Prossimale e Scaffolding

Due concetti già visti in Progettazione, ripresi qui:

Zona di Sviluppo Prossimale (Vygotskij): i sostegni vanno calibrati vicino ai bisogni attuali e modulati man mano che la persona cresce. Se dai sempre lo stesso sostegno per 20 anni senza mai ricalibrarlo, stai bloccando le potenzialità della persona.

Scaffolding (Wood, Bruner e Ross, 1976): "impalcatura" — il sostegno che orienta senza dirigere, che aiuta a risolvere un problema senza sostituirsi. Quando il palazzo è finito, l'impalcatura si toglie. Il rischio opposto: restare sempre col ponteggio alzato, fare le cose al posto della persona invece di supportarla.

Strumento: la SIS

La **Supports Intensity Scale (SIS)**, standardizzata in italiano da Cottini et al. (2008), permette di misurare l'entità dei sostegni di cui una persona necessita per attività adatte alla sua età in ambienti comunitari.

La storia di Marina — esempio concreto

In seminario è stata presentata la testimonianza di **Marina**, 23 anni, con sindrome di Down. Il racconto della madre e di Marina stessa mostra cosa significa un sistema di sostegni costruito nel tempo:

- Sostegni naturali: famiglia, scout, comunità del paese
- Sostegni specialistici: terapisti, docenti, operatori
- Coordinamento: i genitori come coordinatori instancabili della rete (il "caro figlio" di Martinoni — costruire tutto questo richiede enormi risorse di energia e impegno)
- Ambienti inclusivi: scuola dell'infanzia, scout, lavoro in una scuola da 9 anni
- Esiti: Marina ha un lavoro, amici, è diventata zia, si sente parte della comunità

Marina stessa: *"Sono un po' diversa, però sono felice lo stesso."*

Il caso di Marina mostra anche cosa non ha funzionato (una maestra contraria all'inclusione, alcuni genitori diffidenti) — e come si è risposto: informazione, sensibilizzazione, pazienza.

La metafora delle farfalle — Mauro Martinoni

Il prof ha ricordato **Mauro Martinoni**, fondatore della sezione di pedagogia speciale nel Canton Ticino, scomparso giovedì prima della lezione.

La sua metafora più famosa:

"Quando cerchi di afferrare una farfalla ti resta solo un po' di polverina sulle dita e una farfalla morta in mano. Lo stesso capita quando pensi di afferrare l'essenza della persona con un formulario. Le farfalle non si allevano — se si vuole vederne volare in giardino bisogna piantare i fiori, cioè creare le condizioni favorevoli."

Bisogna allenare l'occhio a non vedere solo il bruco, ma la farfalla che verrà. Le diagnosi servono — ma non devono impedirci di vedere la persona.

Concetti chiave

Termine	Significato
AAIDD	American Association on Intellectual and Developmental Disabilities — riferimento definitorio principale
Deficit intellettivo (DI)	Limitazioni nel funzionamento intellettivo + comportamento adattivo, origine prima dei 22 anni
Funzionamento intellettivo	Pensiero, apprendimento, ragionamento, pianificazione, imparare dall'esperienza
Comportamento adattivo	Abilità concettuali, sociali e pratiche per la vita quotidiana
QI	Quoziente Intellettivo; soglia diagnostica per DI: < 70
Curva di Gauss	Distribuzione statistica del QI nella popolazione (media 100, DS 15)
Psicometria	Scienza che misura l'intelligenza tramite test standardizzati
Binet	Padre della psicometria; prima scala di valutazione (1905)

Termine	Significato
Disabilità cognitiva	Termine più ampio che include DI ma anche disturbi dell'apprendimento, ADHD, ecc.
Sistema di sostegno	Rete interconnessa di risorse e strategie per migliorare funzionamento e qualità di vita
SIS	Supports Intensity Scale — scala di misurazione dell'intensità dei sostegni necessari
Scaffolding	Sostegno che orienta senza sostituirsi, modulabile nel tempo
ZSP	Zona di Sviluppo Prossimale (Vygotskij) — area in cui i sostegni sono più efficaci
Sostegni naturali	Sostegni già presenti nell'ambiente (famiglia, amici, comunità)
Sostegni specialistici	Interventi professionali mirati (educatori, terapisti, operatori sociali)

Collegamenti

- **ICF e modello bio-psico-sociale:** già visto nelle lezioni precedenti — qui viene richiamato come strumento per valutare funzionamento e progettare sostegni. Noi operatori guardiamo attività e partecipazione, non solo il deficit.
- **Qualità di vita:** filo conduttore del modulo — i sistemi di sostegno puntano a migliorare la qualità di vita, non a "correggere" la persona.
- **Prossimamente:** approfondimento dei sostegni con la Donatella; sindrome di Down; autismo; intergenerazionalità e invecchiamento.
- **Lettere consigliate:** AAIDD (2022), 12° ed. italiana; Cottini, L. (2016), *L'autodeterminazione nelle persone con disabilità*, Erickson.